PROTOCOLLO 47

Allungamento passivo del massetere

Aumentare l'estensibilità dei muscoli elevatori

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia con limitazione	5 minuti	Ogni seduta

Indicazioni

- ✓ Apertura limitata di origine muscolare
- ✓ Rigidità mattutina
- ✓ Dopo il trattamento dei trigger point

Controindicazioni e precauzioni

- ! Lesioni cutanee, infezioni o tumefazioni locali
- ! Terapia anticoagulante o fragilità vascolare: ridurre la pressione
- ! Sintomi neuropatici o red flags non indagate
- ! Sensibilizzazione marcata: iniziare con intensità minima

Posizionamento

Paziente: supino, capo appoggiato.

Fisioterapista: di lato al paziente, pollice guantato sugli incisivi inferiori.

Esecuzione passo dopo passo



Presa

Pollice sugli incisivi inferiori, l'altra mano stabilizza la fronte.



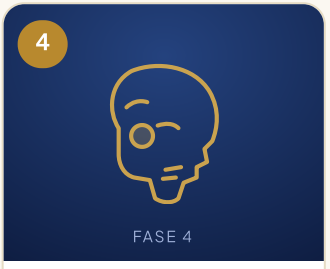
Apertura

Porta la mandibola in apertura fino alla prima resistenza.



Tenuta

Mantieni senza dolore mentre il paziente respira.



Progressione

Avanza leggermente al rilassamento.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Tenuta	30 secondi
Ripetizioni	3
Intensità	tensione, mai dolore

Criteri di rivalutazione

DOLORE ALLA PALPAZIONE	APERTURA MASSIMA	DOLORE RIFERITO
____ / 10	____ mm	Sì / No
sul punto trattato	con calibro	riproduzione del dolore familiare

Punti chiave

- ✓ L'allungamento segue sempre il riscaldamento
- ✓ Respira con il paziente
- ✓ Misura l'apertura prima e dopo

Errori da evitare

- ! Allungare con dolore articolare
- ! Forza sugli incisivi superiori
- ! Rimbalzi

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Autoallungamento	Apertura con le dita sugli incisivi inferiori mantenuta	3 x 30 secondi, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Se compare dolore preauricolare, riduci l'apertura: la limitazione potrebbe essere articolare.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.